DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: DAVID STIVEN ZAPATA PROAÑO **Identificación** CC 1116262052
Edad: 32 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	AMI	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES152 JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL NO ESPECIFICADA

Dx Postoperatorio: K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL NO ESPECIFICADA

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** SEDACION **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 11:30:00 **Hora Final** 11:45:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO BAJO SEDACIÓN ANESTESIOLOGA DRA RODRIGUEZ (FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL).
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE
REALIZADO POR JEISSON HINCAPIE
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: ERGE
SE INTRODUCE GASTROSCOPIO OLYMPUS
ESOFAGO:MUCOSA NORMAL ,PASO FÁCIL POR EL CRICOFARINGEO, PERISTALTISMO, VASCULARIDAD,CONSERVADOS, LINEA A 38 COINCIDE CON LA IMPRESIÓN HIATAL.
ESTOMAGO: EXPLORADO HASTA PÍLORO INCLUYENDO RETROVISIÓN PARA PEQUEÑA CURVA Y FONDO GÁSTRICO NORMALES.
MUCOSA DE CUERPO SIN ALTERACIONES. ANTRO CON EROSIONES DIFUSAS EN REGION PREPILORICA ADEMAS SE EVIDENCIA ULCERA DE ASPECTO PEPTICO DE UNOS 8 MM DE DIAMETRO, CON BORDES ELEVADOS CENTRO CON COAGULO ADHERIDO
DUODENO: NORMAL HASTA LA SEGUNDA PORCION
BIOPSIAS: NO
***CONCLUSION:
1.ULCERA PEPTICA PREPILORICA FORREST II- B CON SIGNOS DE SANGRADO RECIENTE, SIN SIGNOS DE SANGRADO ACTIVO

SE PASA A PROCEDIEMIENTO ENDOSCOPICO CONTROL DE HEMORRAGIAS ECLEROTERAPIA
Complicaciones : **SI** [ ] **NO** [X]

Hallazgos :
CODIGO PROCEDIMIENTO ENDOSCOPICO PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS DIGERSTIVAS
434102
*** ESCLEROTERAPIA****
PROCEDIMIENTO:
EXPLORADO HASTA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, SE OBSERVÓ ÚLCERA DE APROX 8 MM DE DIÁMETRO EN REGION PREPILORICA CON COAGULO ADHERIDO , BORDES ELEVADOS, FRIABLES DE FÁCIL SANGRADO AL CONTACTO CON EL EQUIPO, SE INYECTO CON SOLUCIÓN DE ADRENALINA 1:10000 NO. 9CC EN LOS CUATRO CUADRANTES SIN COMPLICACIONES APARENTES.
CONCLUSION:
1. SIGNOS DE HEMORRGIA RECIENTE ULCERA PEPTICA PREPILORICA FORREST II-B
2.INYECCIÓN ENDOSCÓPICA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

3. ESCLEROTERAPIA SIN COMPLICACIONES.

Tejidos enviados a patología : SI ☐ **NO** ☒

JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ
Reg. 1115066530
CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

***** FIN DEL REPORTE *****